

УДК: 616-006.6

Лигаи А.Л.

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Хирургиялық профильдегі онкологиялық науқастардың кардиальды тәуекелі

Тужырым. Орналасуы бойынша әр түрлі ісіктермен операция жасалған 1155 науқас зерттелді. 36% науқастарда қосалқы жүрек-қантамыр ауруы анықталған, солардың ішінде негізгі топты құрайтын – 29,5% артериальді гипертензия. Қосалқы жүрек-қантамыр ауруы бар науқастардың операциялық емнің кардиальды тәуекелдері анықталды. Науқастардың көпшілігі артериальді гипертензияға қарсы тиянақты ем қабылдамаған. Алынған қорытындылар негізінде науқастарды операцияға дейінгі зерттеу жүргізу мен операцияға дайындық оптимизациясына кеңес берілген.

Түйінді сөздер: кардиальды тәуекел, онкологиялық науқастар, артериальды гипертензия.

Өзектілік

Жүрек-қантамыр аурулары мен онкологиялық аурулар өлімнің негізгі себептері болып келетіні барлығына анық. Қосалқы жүрек-қантамыр ауруы онкологиялық аурудың ағымын біршама күрделендіреді. Онкологиялық ауру еміндегі негізгі әдіс болып хирургиялық операция табылады. Ал артериальді гипертензия, жүректің ишемиялық ауруы, созылмалы жүрек жетіспеушілігі сияқты аурулар хирургиялық операция өткізудің кардиальды тәуекелін жоғарылатады.

Мақсаты

Онкологиялық науқастардың кардиологиялық аурулар құрылымын және хирургиялық профильдегі науқастардың операциялық араласу кезіндегі кардиальді тәуекелін бағалау.

Зерттеу әдістері мен ақпараты

2011 ж. Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының (ҚазОЖРҒЗИ) урологиялық, торакоабдоминальді, гинекология және маммология, бас және мойын ісіктері хирургиялық бөлімдерінде емдеуде жатқан 1155 науқас зерттелді. Сырқатнамалар ішінен антропометриялық параметрлерді, негізгі сықат сипаты және қосалқы жүрек-қантамыр патологиясын, жасалған операциялар сипатын, кардиолог қарауының берілгендері мен өткізген зерттеу әдістерін тіркеді. Электрокардиограмма (ЭКГ) және эхокардиография берілгендерін анализ жасады. ЖИА мен АГ қарсы тиянақты ем қабылдағанын анықтады. Систолалық артериалдық қысым (Сист АҚ), диастолалық артериалдық қысым (ДАҚ) және жүрек жиырылу жиілігі (ЖЖЖ) берілгендерін зерттеудің 4 кезеңдерінде тіркеді. Аталған көрсеткіштерді келесі кезеңдерде зерттеді:

1. емдеуші дәрігердің науқас түскен кездегі қарауы;

2. Операция алдында анестезиолог қарауы

3. Операция аяқталысымен жансақтау және қарқынды емдеу бөлімі немесе ояну палатасында;

4. Ауруханадан шығар алдында.

Науқастарды таңдау кезінде операция жасалмаған, сонымен қатар жоғарғы анестезиологиялық қауіп себебінен операцияға алынбаған науқастар есепке алынбады. Статистикалық өңдеуді Microsoft Excel 2003 программасы көмегімен жүргізді. Берілгендер $M \pm SD$ түрінде көрсетілген (Орташа арифметикалық стандартты ауытқу).

Қорытындылар мен талдау. Науқастардың орташа жасы 52 ± 11 жас, бойы 166 ± 14 см, салмағы 67 ± 15 кг құраған. Ер адамдар 546 (47%), әйел адамдар 604 (53%). Әйел адамдардың көп болуы гинекология және маммология бөлімін 100% әйелдер құрағаны түсіндіреді. Науқастардың орта жасына қарағанда операцияға негізінен еңбекке қабілетті жастағы адамдар алынатыны анық. Кардиолог операцияға дейін 308 (26,6%) науқасты қараған. Операцияға дайындық кезінде жүрек-қантамыр жүйесін клиникалық зерттеу мен бағалау ең маңызды кезең болып табылады. Қазіргі кезде Қаз ОЖР ҒЗИ-да кардиолог кеңесіне көрсетілім болып: жүрек-қантамыр жүйесі жағынан шағымдар, бастан өткізген немесе қазіргі кездегі жүрек-қантамыр ауруы, ЭКГ-дағы патологиялық өзгерістер, 50 жасан асқан науқастар табылады. Алынған мәліметтер негізінде болатын операция және мүмкін болатын асқынуларды болжауға болады. Бұл жағдайда біз кейбір қиындықтарды кездестірдік, себебі науқастарда жүрек-қантамыр жүйесі ағзалары ауруына шағым, анамнез және мұндай ауруға тиісті медициналық құжаттар болмайды, және де жалғыз ЭКГ ауру диагностикасына жеткіліксіз болады. Коронарлы тамырлар патологиясы, әсіресе ЖИА кезінде оны анықтау үшін салмақ түсіретін сынамалар, мүмкін коронарография да керек (ЖИА анықтауында алтын стандарт), және де ЭКГ миокардтың анық жағдайын көрсетпейді. ЭКГ – тек жалғыз жағдайды дәл анықтайды – ол жүрек ырғағының бұзылыстары. Дүние жүзінде қолданатын Американдық кардиологтар ұйымының төрт бастпалы бағалау шкаласымен қатар кардиальді тәуекелдің бірнеше сенімді жіктелулері ұсынылған, алайда оның әрқайсысы ұпайлар санауын талап етеді. Бұл тәжірибелі дәрігер көзқарасы бойынша маңызды емес. Дәрігерге науқас операцияны көтере алу-алмауын білген маңыздырақ, ал егер көтере алса – қандай асқынулар болуы мүмкін және асқынулардың алдын алу үшін не істеу керек екені маңызды [3].

Ең көп жүрек-қантамырлық асқынулар (4%) қолқаға жасалатын үлкен операциялардан соң (мысалы, құрсақ аортасын протездеу), кеуде қуысында (мысалы, өкпе резекциясы) және құрсақ қуысында жасалатын операциялардан соң (ішек резекциясы) кездеседі. Үлкен ортопедиялық операциялардан соң жүрек-қантамырлық асқынулар аз – 1%, ал офтальмологиялық операция және трансуретральді резекциялар толық қауіпсіз болып

есептеледі. Операция ұзақтығы өздігінен болжамдық фактор емес, одан да маңыздырақ болып операция жасау кезі табылады: операциядан кейінгі миокард инфарктынан және жүрек-қантамыр ауруынан өлім жоспарлы операцияға қарағанда жедел операциядан кейін 4 есе артық [4].

Қаралған 105 (34%) науқаста жоғарғы кардиальді тәуекел, 110(35,7%) науқаста – орташа, және 93 (30%) науқаста - төмен кардиальді тәуекел анықталды. 12 (3,8%) науқаста өте жоғарғы кардиальді қауіп болған, сол себепті олардың операциясы тек өмірлік көрсеткіштер бойынша жасалған. АГ 341 (29,5%) науқаста анықталды. ЖИА 165 (14,2%) науқаста анықталған. 101 науқаста (8,7%) АГ және ЖИА бірлесе кездескен. Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің 1 сатысы - 246 (24%), СЖЖ 11А-Б – 17 (1,4%) науқаста кездескен. Қалған патологиясы бар науқастар (ақаулар, нейроциркуляторлы дистония, миокардодистрофиялар) 1% - дан аз болған. Барлығы қосалқы жүрек-қантамыр аурулармен 416 (36%) науқас болған. Сөйтіп, науқастардың үштен бірінде АГ немесе ЖИА кездескен. Сонда кардиолог 26,6% науқастарды қараған, ал қосалқы жүрек-қантамыр аурулары бар науқастар 36% құрағаны қалайша? Бұл жағдайды науқастардың көбін кардиолог консультациясы операциядан кейін ЭКГ-дағы өзгерістер немесе клиникалық көрініске байланысты тағайындалғандығы түсіндіреді. Және қарау кезінде АГ немесе ЖИА анықталған. Сонымен қатар, науқастардың бір бөлігі басқа клиникадан АГ немесе ЖИА қойылған дайын диагнозбен, көшірме және кеңестермен түскен.

Қалыпты ЭКГ 633 науқаста (54,8%) болған. Сол қарынша гипертрофиясы 127 (10,9%) жағдайда, Гис шоғырының оң немесе сол аяқшасының толық емес блокадасы – 74 (6,4%), диффузды өзгерістер – 92 (7,9%), реполяризация процесінің бұзылыстары - 70 (6%), синусты тахикардия – 77(6,6%), ишемия немесе коронарлы жетіспеушілік – 19 (1,6%), жыпылықтағыш аритмия – 15 (1,3%), экстрасистолия – 36 (3,1%), брадикардия 12 (1%) кездескен. Науқастардың жартысына жуық ЭКГ-да өзгерістер болғанымен, негізінен қауіпсіз, бірақ миокард ишемиясы мен ырғақ бұзылысы – 19 (1,6%) қауіпті. Эхокардиография 62 науқасқа (5,3%) жасалған. Айдау фракциясы 64,2±6%, дельта S 32,5±4,7. Эхокардиография өткізілген науқастар пайызы өте аз. Зерттеудің тек осы түрі миокардтың функциональді жағдайын бағалауда ең объективті болып табылады. СЖЖ сол қарынша геометриясының өзгерісімен, миокардтың концентрлік гипертрофиясымен және диастолиялық дисфункциямен сипатталады [5].

Операцияға дейінгі гипотензивті терапияны талдау барысында қызық берілгендер алынды. Ангиотензин айналдырғыш фермент ингибиторларын (ИАПФ) операцияға дейін 118 (10,2%) науқас, бета-блокаторларды 85(7,3%), кальций иондарының антагонистерін 36 (3,1%) науқас қабылдаған. Үнемі гипотензивті дәрілерді қабылдаған барлығы 256 (22%) науқас болған. Бұл барлық науқастардың үштен бірінде қосалқы жүрек-қантамыр аурулары анықталғанына қарамастан. Сөйтіп, науқастардың көпшілігі ЖИА мен АГ байланысты ешқандай ем қабылдамаған.

Мұндай жоғары пайызды АГ кезінде периперационды кезеңде қарқынды ем дәрігерлеріне гипертонзияның көріністерімен кездесіп, артериялық қысымды қолда бар тәсілдермен төмендетуге тура келеді. Қазіргі кезде ҚазОЖР ҒЗИ –да қарқынды ем бөлімінде негізгі дәрілік зат болып Изокет немесе Изомик табылады. Жүрек пен қан тамырларына нитропрепараттардың оң фармакологиялық

әсеріне қарамастан, нитропрепараттар ЖИА еміне арналғанын ұмытпау керек, ал артериальдық қысымның төмендеуі – олардың жанама әсері [6]. Соңғы жылдары вена ішіне енгізілетін дәрілік зат – Энап пайда болды. Бірақ Энаптың әсері шектелген, себебі операциядан кейінгі уақытта операциялық стресс ретінде пайда болатын перифериялық артериялар спазмын және жүректің шамадан тыс жұмысын төмендеті алмайды. Сондықтан операциядан кейінгі науқастарда АГ емінде таңдамалы болып Альфа-адреноблокаторлық әсері бар Урапидил сияқты дәрілік зат табылады. Бета-адреноблокаторлармен ем қабылдаған науқастар пайызы аз екенін байқауға болады. Тек бета-адреноблокаторлар қазіргі таңда АГ,ЖИА,СЖЖ сияқты жағдайларда негізгі ем ретінде ең қолайлы болып табылады, және де науқастардың өмірінің ұзақтығын жоғарылатады [8,9].

Алынған берілгендер негізінде қазіргі уақытта ҚазОЖРҒЗИ-да науқастардың жағдайын операция алды бағалау мен дайындау жолдары өзгертілді. Барлық науқастарға міндетті болып кардиолог консультациясы табылады. Эхокардиография көмегімен тексерілетін науқастар саны көбейді. Жүрек-қантамыр ауруларының алдын алуға және уақтылы кардиологқа тексерілуге белсенді үгіт-насихат жүргізілуде.

Қорытындылар:

1. Онкологиялық науқастардың жартысына жуығында қосалқы жүрек-қантамыр ауруы бар, солардың ішінде артериальді гипертензия басым.

2. Науқастың операция алды жағдайын толық бағалау үшін эхокардиография, салмақтық сынамалар, және көрсетілімді бойынша коронарография жасау керек, алдын алу үшін кардиологқа ерте қаралу керек.

3. Қарқынды ем бөлімі дәрігерлерінің қолында артериальді гипертензияны реттеуге арналған венаішілік енгізілетін Эбрантил, Энап сияқты дәрілік заттар болуы тиіс.

4. Қосалқы жүрек-қантамырлары ауруы бар науқастарды мұқият тексеру және кардиальді тәуекелді дұрыс бағалау бұрын операция алынбаған науқастарға күрделі операция жасауға мүмкіндік береді.

Әдебиет тізімі

1. Шевченко Н.М.. Кардиология.- 2004.- С. 46.
2. Alexander R.V., Schlant R.S. The Heart arteries and veins /в кн.: Клиническая кардиология.- 2002.- 529с.
3. Чазов Е.И. Болезни сердца и сосудов.-М., 1992.- Т-4.-С. 404 .
4. Фрид М., Грайнс С. Кардиология в таблицах и схемах / Пер. с англ. –М.,1996.- 420с.
6. Бажикова С.Л., Уразалина С.Ж. Взаимосвязь структурно-геометрических изменений левого желудочка, диастолической функции желудочков с функциональным состоянием предсердий у больных хронической сердечной недостаточностью // Терапевтический вестник.- 2006.- №1.- С.3-5.
- 7.Курбанов Р.Д. Современные аспекты применения нитратов в кардиологии // Восточные вести – Medical Express.- 2001.- №7.- С.18.
8. Турзунова Л.Г., Досмагамбетова Р.С., Дюсембаев Е.Е., Бадина Л.К. Влияние Эгилока на функциональное состояние левого желудочка и качество жизни больных с артериальной гипертензией и перенесенным инфарктом миокарда // Медицина.- 2002.- №6.- С.24-27.
9. Голицын С.П. Лечение желудочковых аритмий с позиции первичной и вторичной профилактики внезапной смерти // Сердечная недостаточность.-2005.- Т. 2, №5.- С.201-208.

*Аннотация**Лигаи А.Л.**Казахский НИИ онкологии и радиологии**Кардиальный риск у онкологических больных хирургического профиля*

Было обследовано 1155 пациентов, оперированных по поводу опухолей различной локализации. У 36% пациентов диагностирована сопутствующая сердечно-сосудистая патология, в основной массе артериальная гипертензия – 29,5%. Произведена оценка кардиального риска оперативного лечения на основании наличия сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Выяснено, что основная масса пациентов регулярного лечения по поводу артериальной гипертензии не получала. На основании полученных данных сделаны рекомендации по оптимизации предоперационного обследования и подготовки пациентов.

Ключевые слова: кардиоваскулярная гипертензия, он-

кологические пациенты, предоперационная подготовка.

*Summary**A.L. Ligay**Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology**Cardiac risk of cancer surgical patients*

One thousand one hundred and fifteen patients have been studied after surgery due to cancer of different location. 36.0% were suffered from any type of concomitant cardiovascular pathology. The most common type of cardiovascular pathology was arterial hypertension (29.5%). The cardiac risk of surgery has been estimated based on concurrent cardiovascular pathology. It has been found that majority of patients were treated by not regular regimen. Based on the collected data we formulated the recommendations for optimal preoperative checking and preparation.

Keywords: cardiovascular disease, cancer patients, preoperative obsldovanie.